

Tên thú cưng: Phô Mai

Tên chủ: Anh Thiện

Ngày: 06/07/2026

Tuổi: 6 tuổi

Số điện thoại: 0353254445

Bác sĩ thực hiện:

Loài: Mèo

Địa chỉ:

Dr. Ngô Công Thắng

Giới tính: Đực

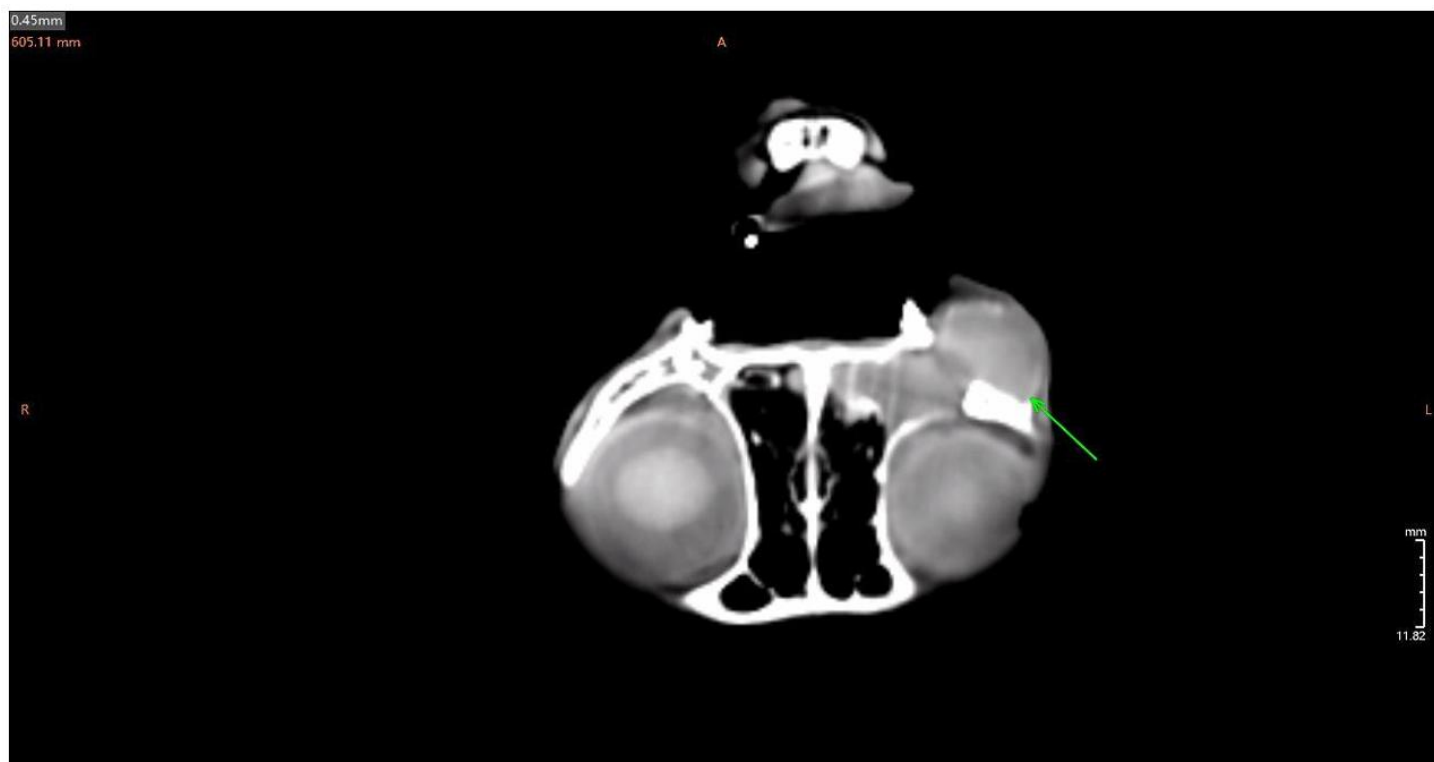
Vị trí quét: Toàn thân

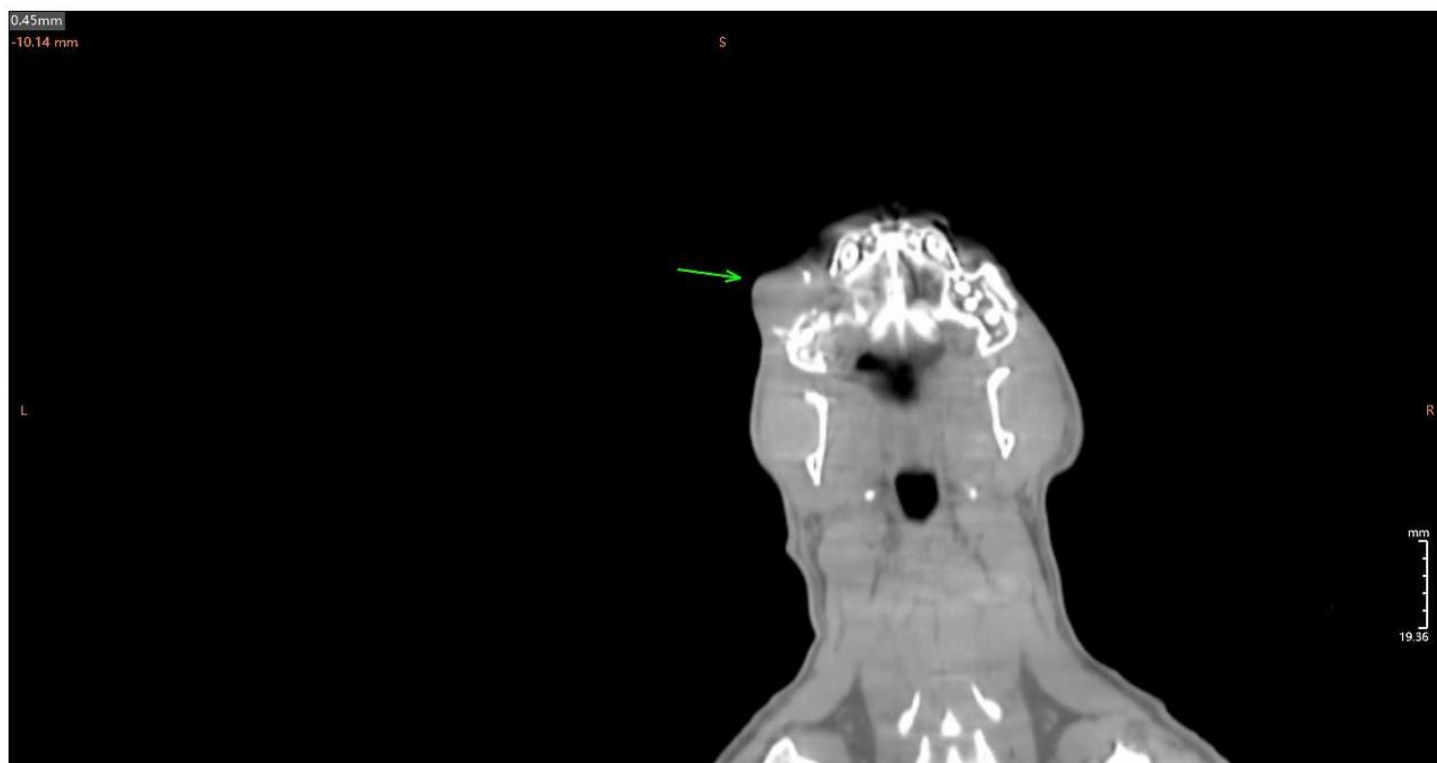
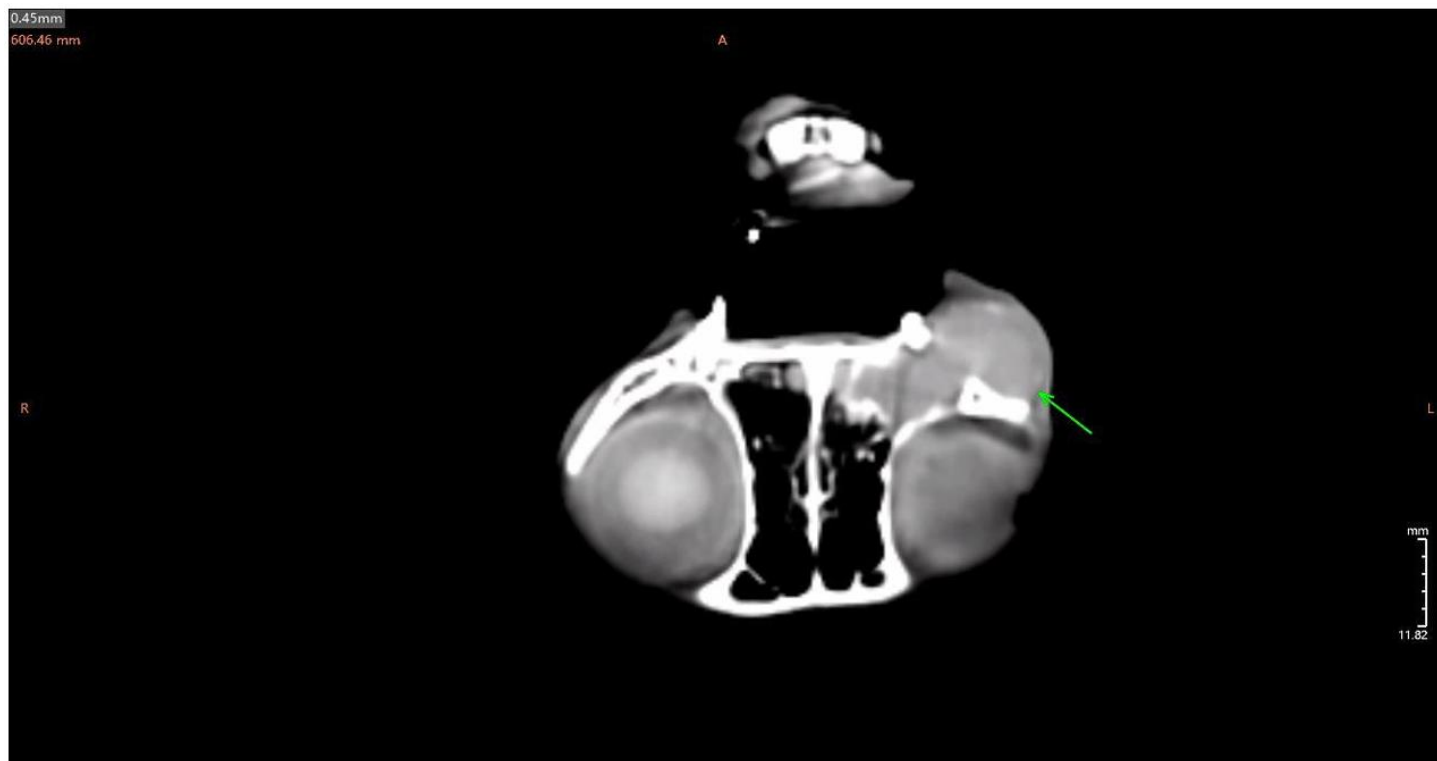
Tóm tắt bệnh sử lâm sàng:

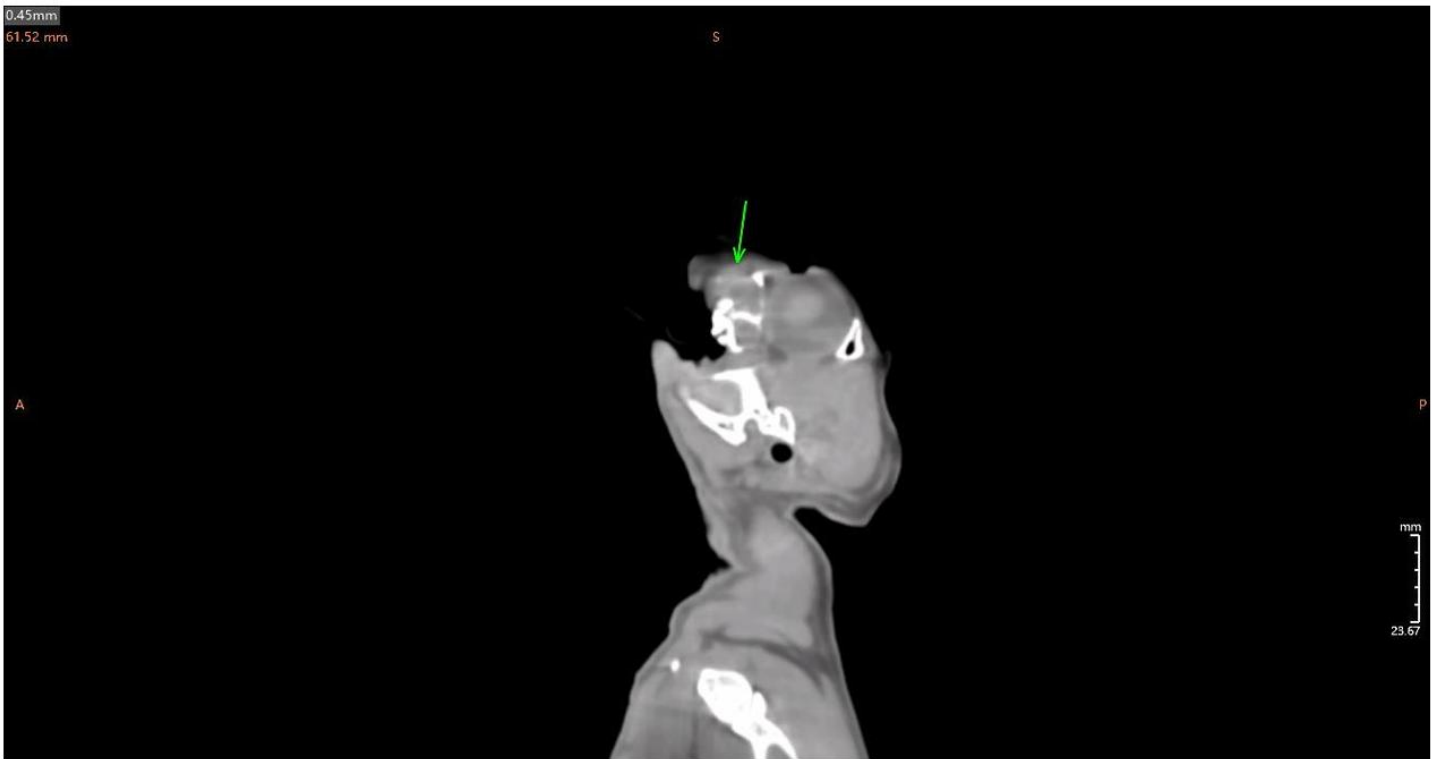
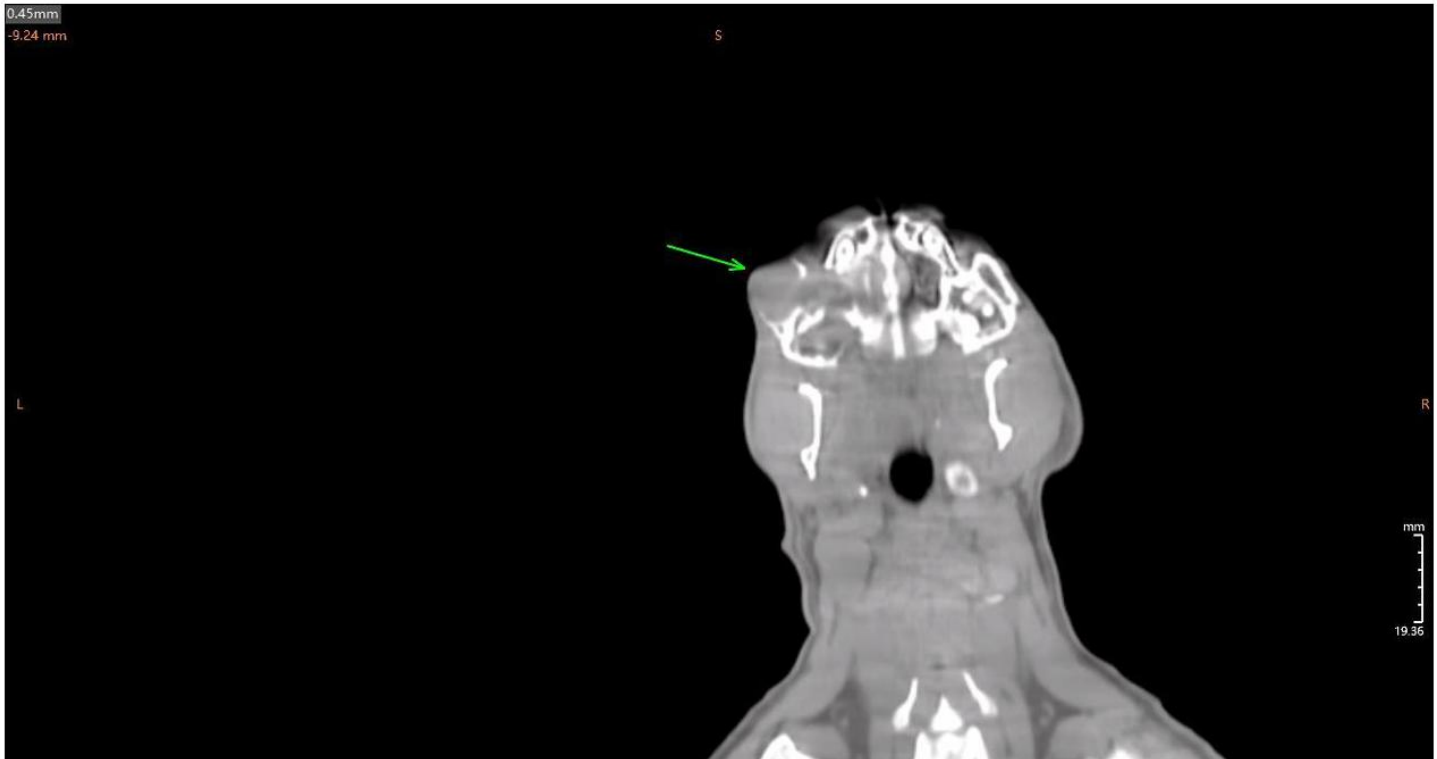
Thú cưng bị chảy nước mắt ở mắt trái khoảng 1 năm nay. Khoảng 3 tuần trước, chủ nuôi sờ thấy một khối bất thường ở bên trái mắt. Thú cưng đã được đưa đến một phòng khám khác để điều trị bằng thuốc kháng sinh và thuốc kháng viêm, nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.

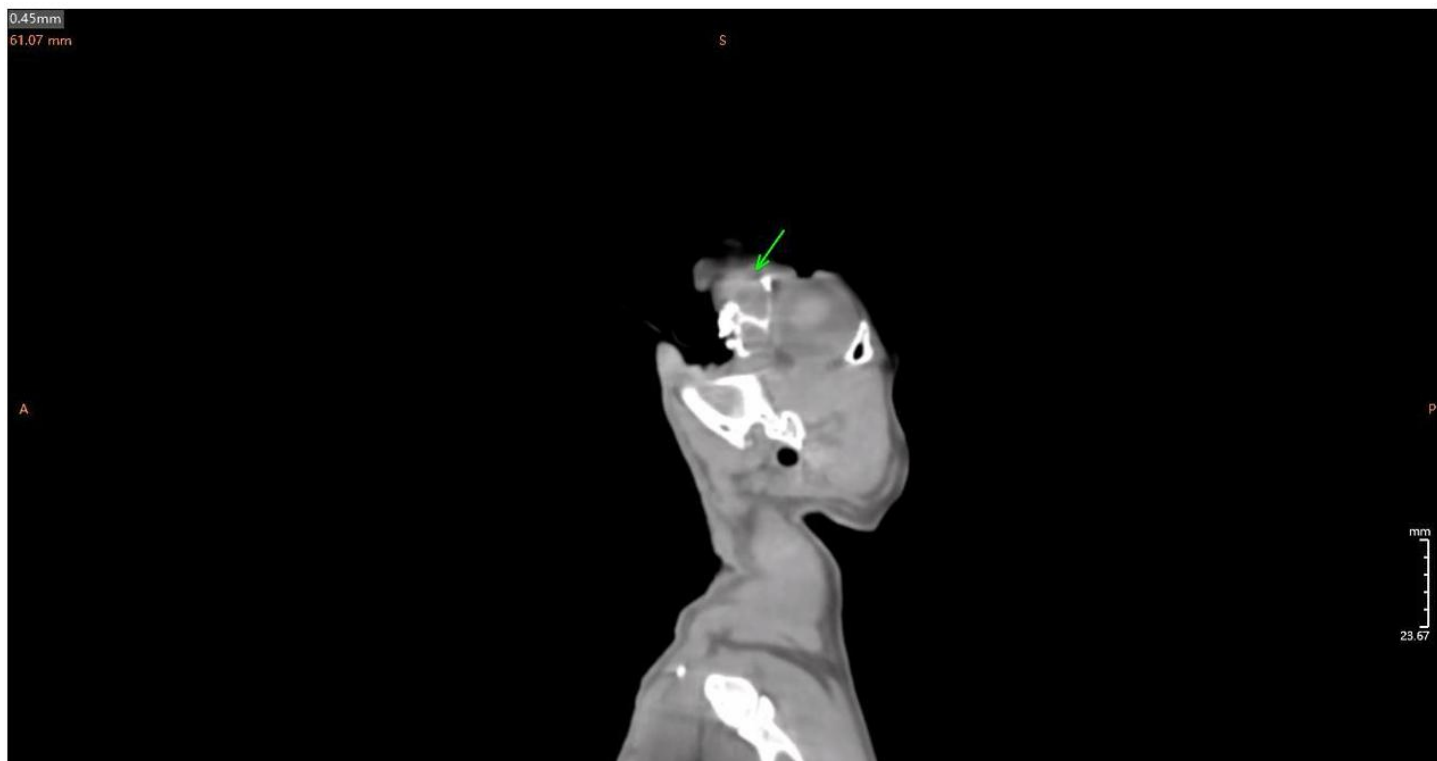
Nhận định hình ảnh:

Hình ảnh chỉ hiển thị một phần, các hình ảnh khác xem trong file nguồn.

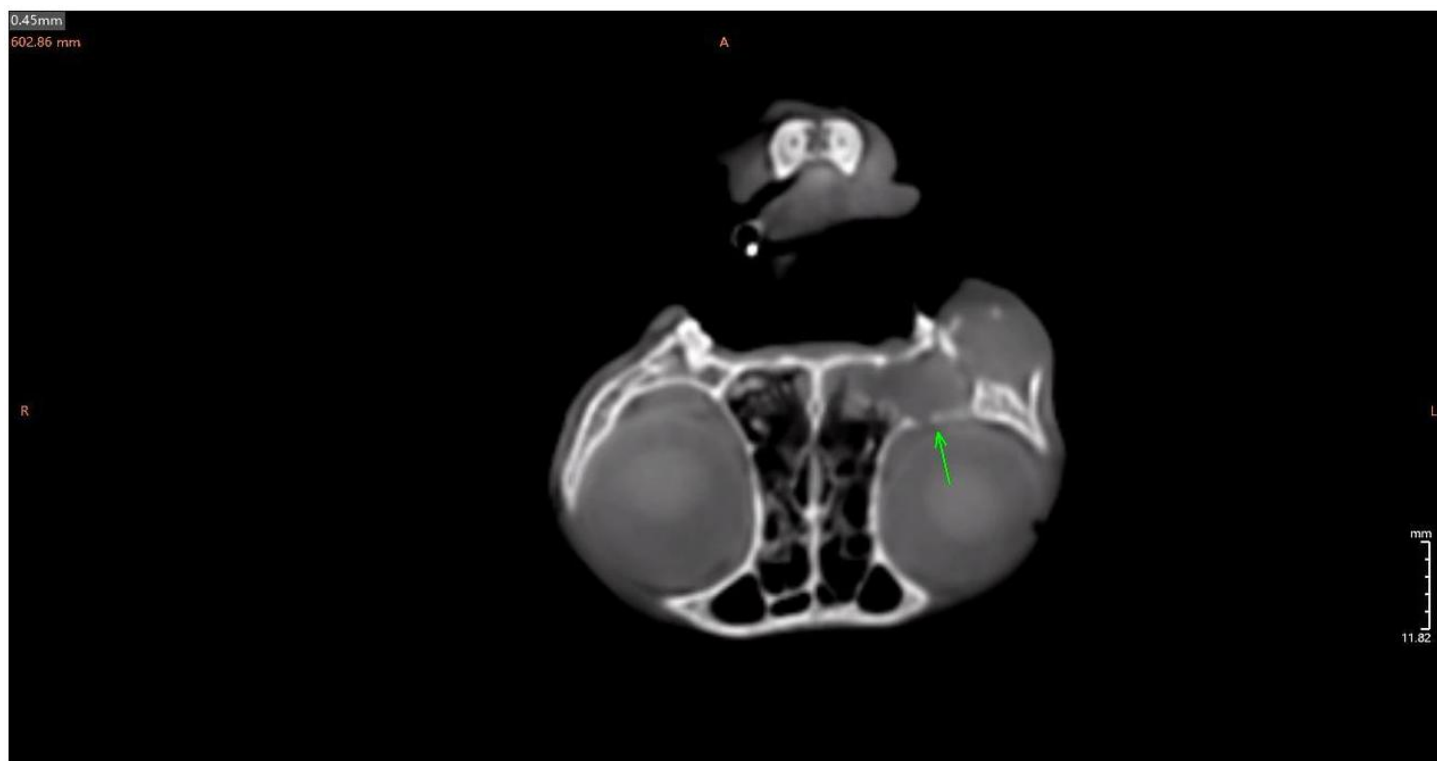


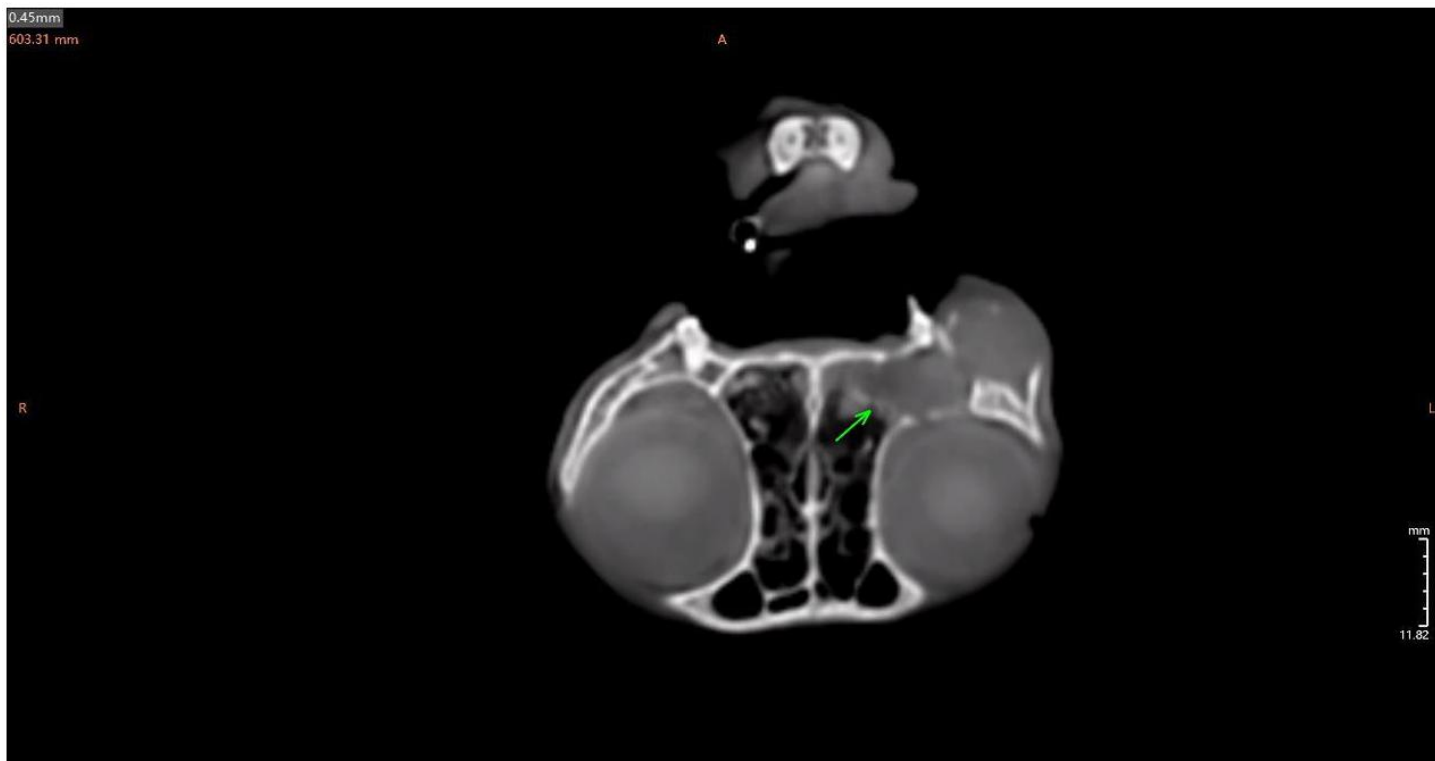




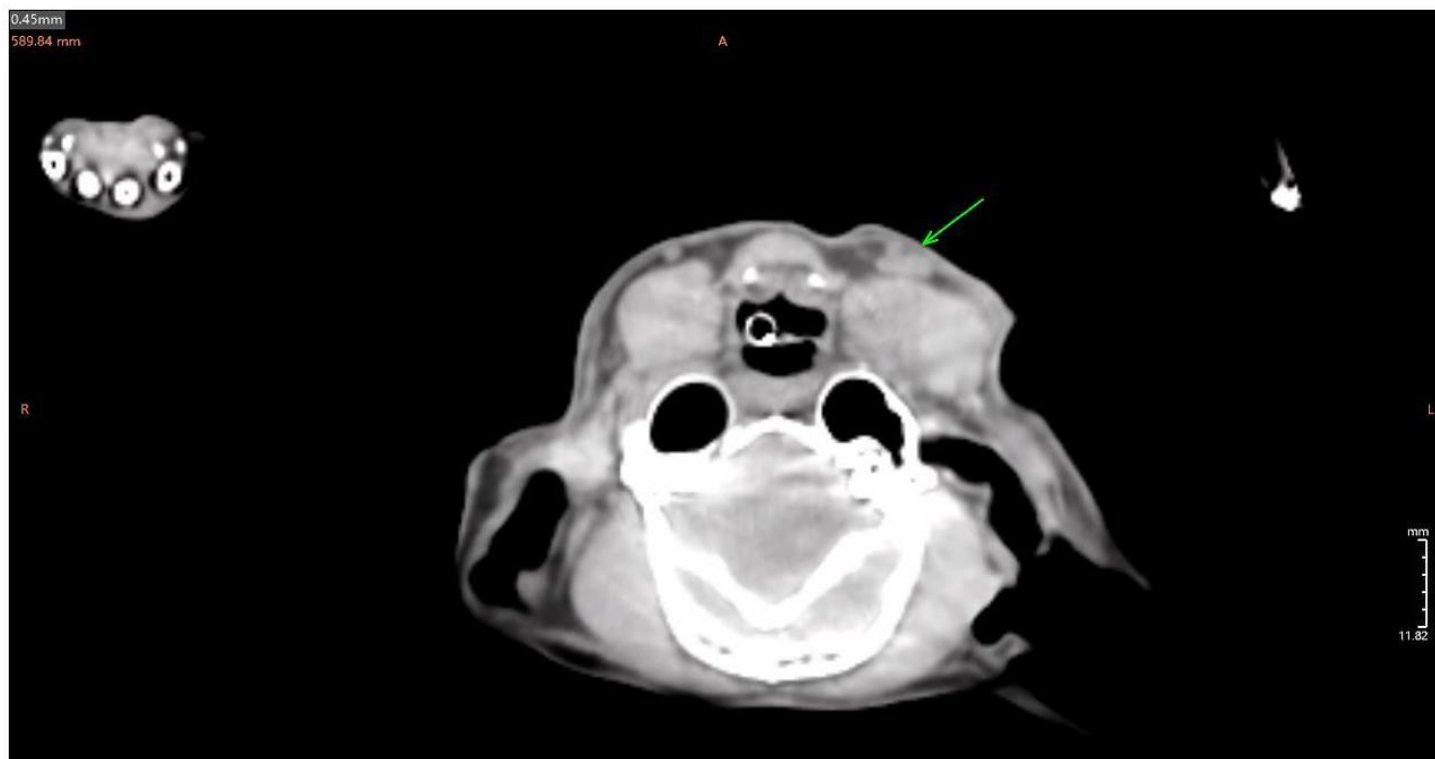


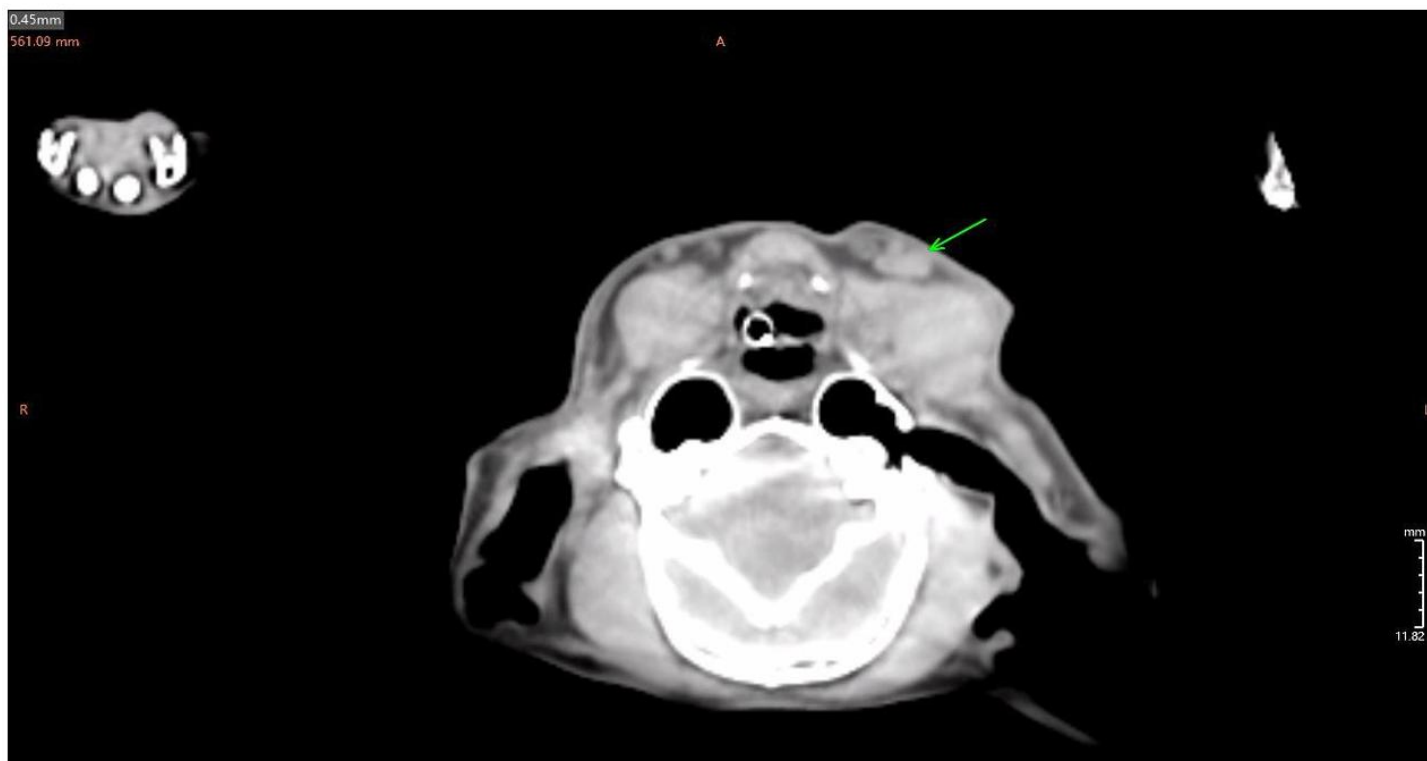
Phát hiện có tổn thương chiếm chỗ ở vùng xương ổ răng bên trái.





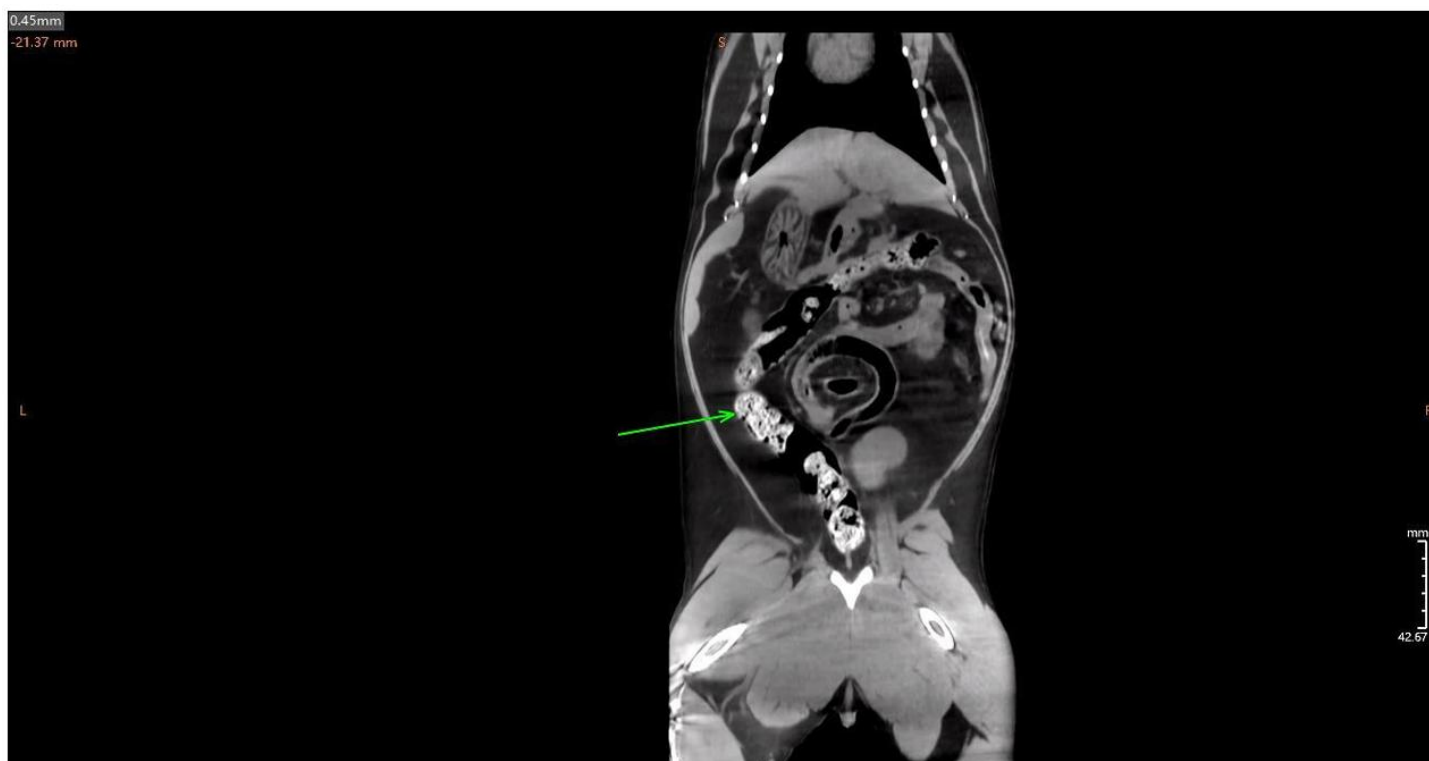
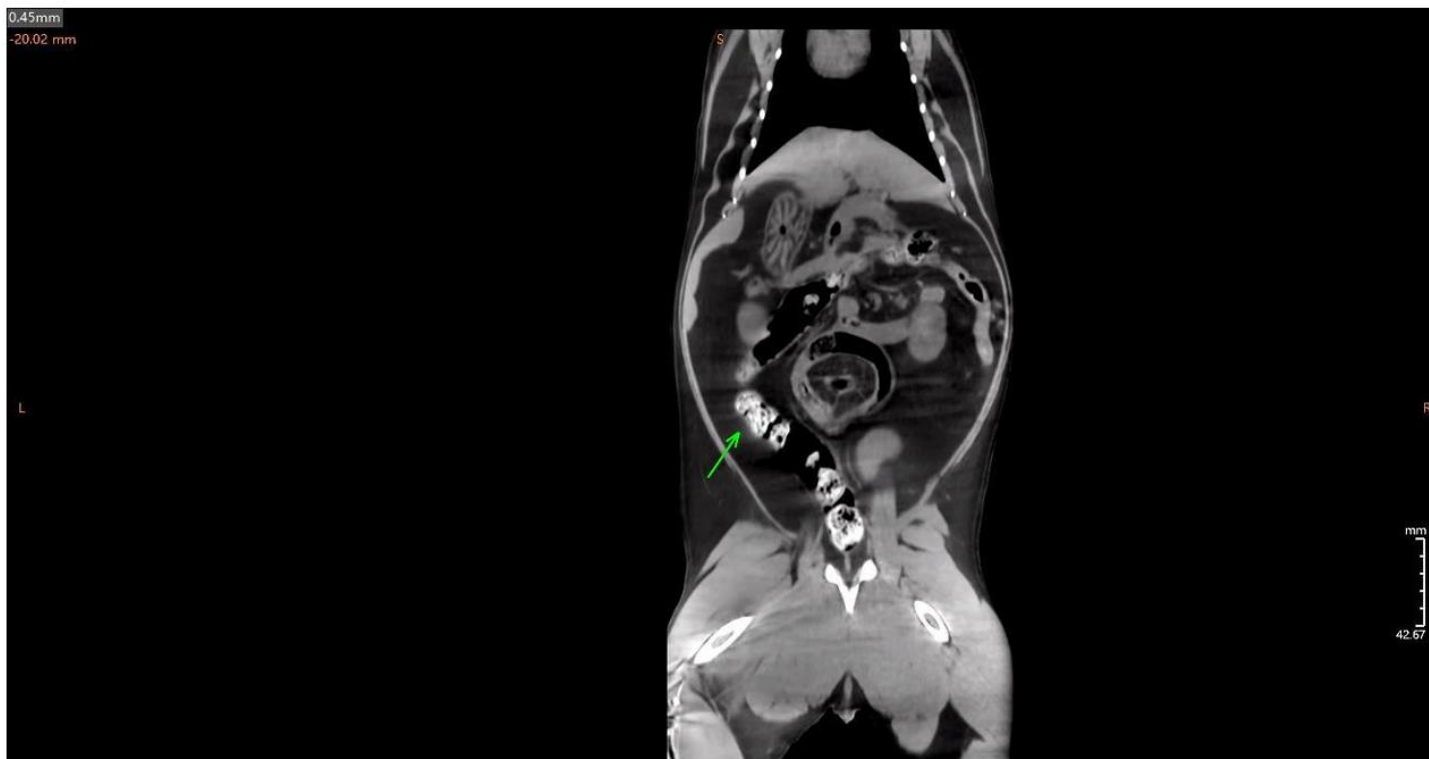
Có một khối/tổn thương bất thường ở vùng xương ổ răng bên trái, kèm phá hủy xương thành hốc mắt bên trái.



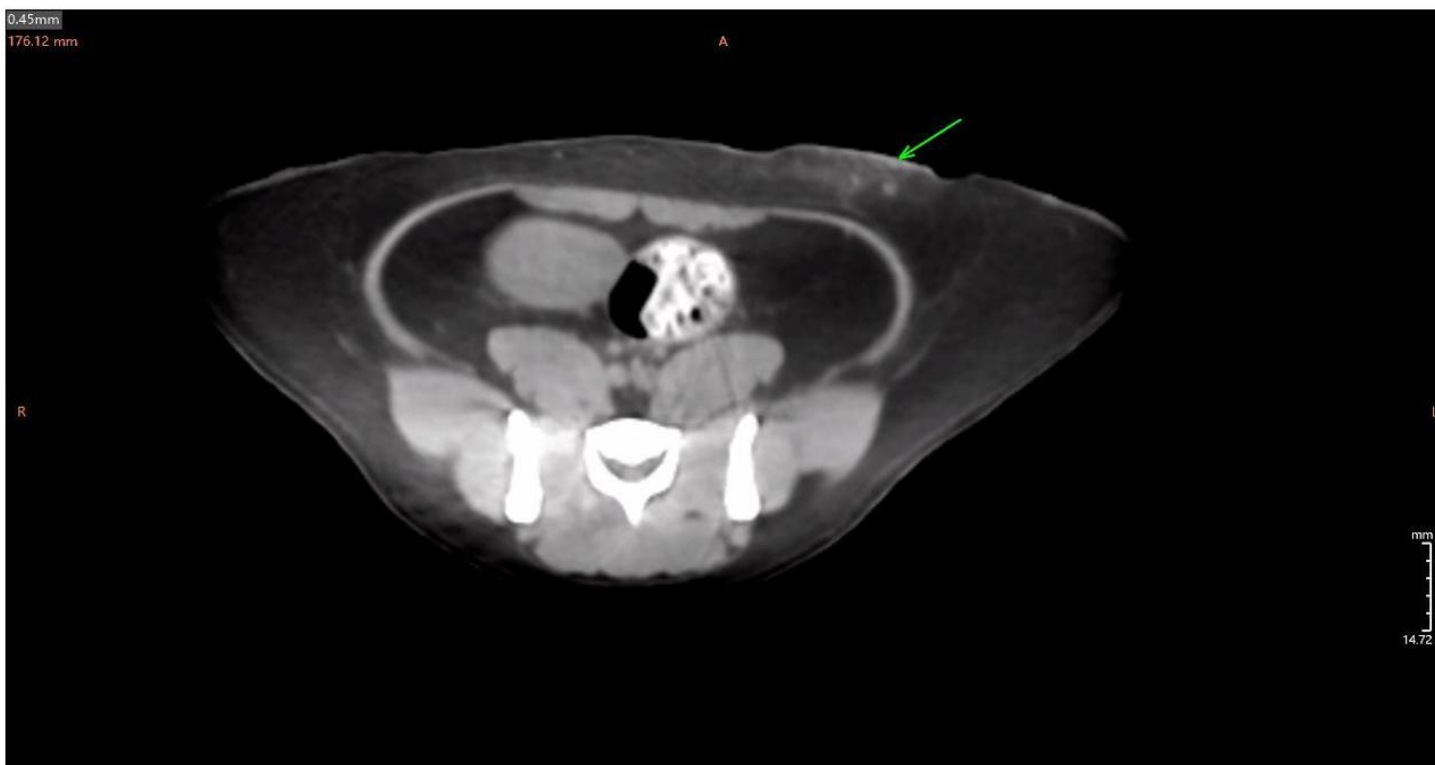
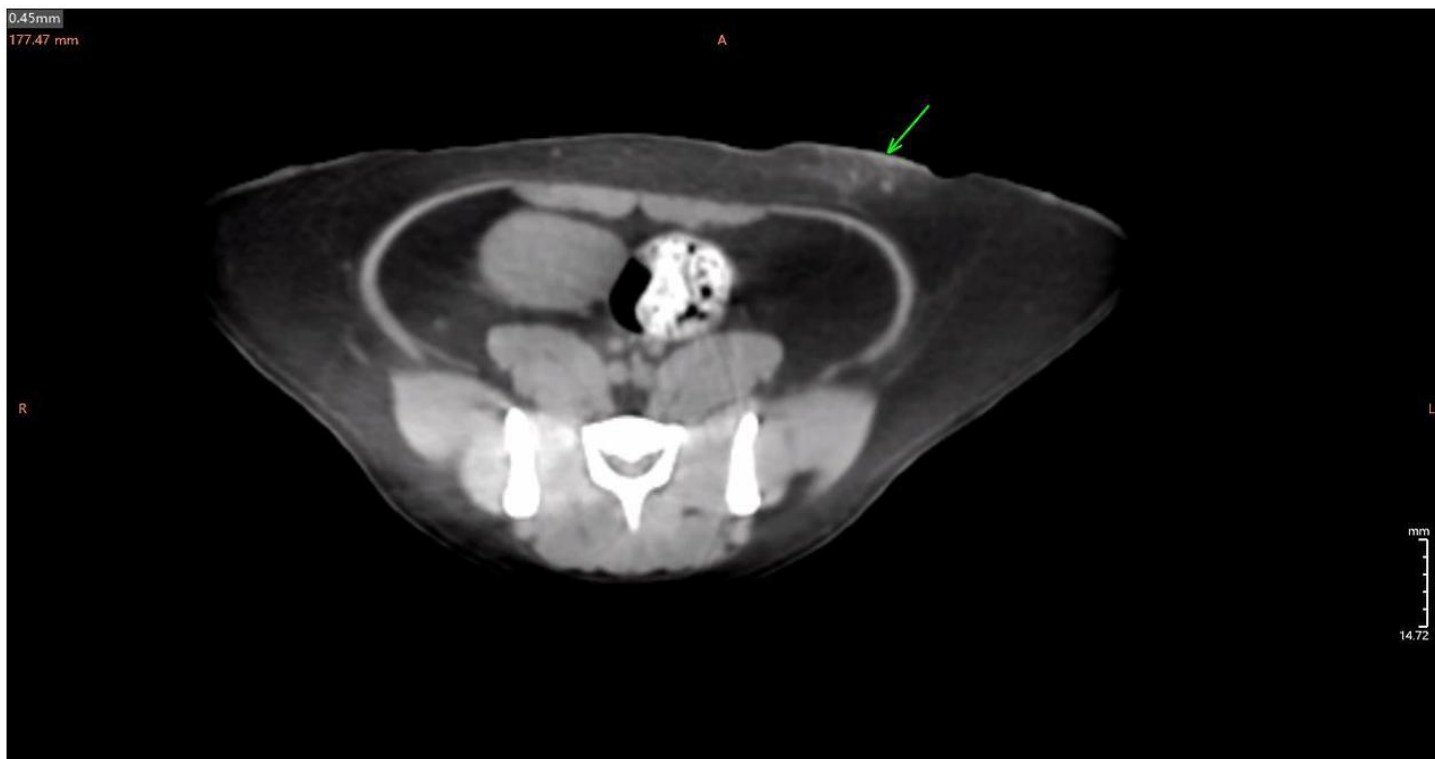


Ghi nhận nhiều hạch lympho nhỏ ở vùng cổ hai bên, trong đó một vài hạch hơi to nhẹ.





Đại tràng và trực tràng bị giãn do ứ đọng phân.



Ghi nhận sưng nhẹ mô mềm dưới da dọc theo thành chậu trước bên trái.

Vùng não và sọ:

1. Hai bán cầu đại não cân xứng. Không ghi nhận tổn thương bất thường về đậm độ trong nhu mô não. Các cấu trúc đường giữa nằm đúng vị trí. Não thất có kích thước và hình dạng bình thường. Không ghi nhận giãn rõ các rãnh não hoặc khe não. Các xương sọ quan sát được không thấy bất thường rõ ràng.

2. Hai ống tai ngoài thông thoáng, niêm mạc/đường viền trơn láng; không ghi nhận tổn thương mô mềm đáng chú ý. Hai bóng nhĩ và khoang tai giữa không thấy chất/dịch bất thường. Ghi nhận một khối dạng thùy, tăng đậm độ nhẹ tại vùng xương ổ răng bên trái, lan đến vùng xoang sàng, bờ không rõ, kích thước khoảng 2,5 cm × 1,5 cm. Có hiện tượng tiêu xương và phá hủy xương tại thành hốc mắt trái, thành xoang sàng và vùng xương ổ răng hàm trên. Ghi nhận nhiều hạch lympho nhỏ ở vùng cổ hai bên, trong đó một số hạch hơi to nhẹ.

Vùng ngực:

1. Lồng ngực cân xứng. Không ghi nhận vùng mờ bất thường trong nhu mô phổi hai bên. Khí quản nằm đúng đường giữa; khí quản và phế quản không bị tắc nghẽn. Bóng tim và các mạch máu lớn có hình thái bình thường. Rốn phổi hai bên không to. Trung thất không bị lệch, không ghi nhận hạch rốn phổi hoặc hạch trung thất to rõ. Không có dấu hiệu tràn dịch màng phổi hai bên.

Vùng bụng và chậu:

1. Gan có hình dạng bình thường, bao gan nguyên vẹn; không ghi nhận tổn thương bất thường trong nhu mô gan. Đường mật trong gan và ngoài gan không giãn. Túi mật có kích thước bình thường, thành trơn láng, không thấy chất bất thường bên trong. Tụy có hình dạng và đậm độ bình thường, không giãn ống tụy. Lách có hình dạng đều, đậm độ đồng nhất, không thấy tổn thương khu trú. Hai thận có đường bờ đều, không ghi nhận tổn thương bất thường trong nhu mô thận. Không ghi nhận hạch to rõ hoặc dịch ổ bụng.

2. Bàng quang căng vừa đủ, không thấy chất bất thường trong lòng bàng quang. Không ghi nhận hạch vùng chậu to. Đại tràng và trực tràng giãn do ứ phân. Ghi nhận sưng nhẹ mô mềm dưới da dọc theo thành chậu trước bên trái.

Cột sống:

1. Trục cột sống bình thường. Không ghi nhận dấu hiệu phá hủy xương ở các thân đốt sống quan sát được. Không thấy phồng hoặc thoát vị đĩa đệm. Không ghi nhận tổn thương bất thường về đậm độ trong ống sống.

Kết luận hình ảnh:

1. Ghi nhận một khối/tổn thương chiếm chỗ ở vùng xương ổ răng bên trái, lan đến xoang sàng, kèm theo tiêu xương và phá hủy xương tại thành hốc mắt trái, thành xoang sàng và xương ổ răng hàm trên; chưa thể loại trừ khối u ác tính.

2. Ghi nhận nhiều hạch lympho nhỏ ở vùng cổ hai bên, trong đó một số hạch hơi to nhẹ.

3. Đại tràng và trực tràng giãn do ứ phân.

4. Ghi nhận sưng nhẹ mô mềm dưới da dọc theo thành chậu trước bên trái.

Khuyến nghị điều trị:

1. Ghi nhận khối/tổn thương chiếm chỗ ở vùng xương ổ răng bên trái, kèm theo tiêu xương và phá hủy xương tại thành hốc mắt trái, thành xoang sàng và xương ổ răng hàm trên. Chưa thể loại trừ khối u ác tính. Khuyến nghị chụp CT có tiêm thuốc cản quang thêm, kết hợp với xét nghiệm mô bệnh học để xác nhận chẩn đoán.
2. Ghi nhận nhiều hạch lympho nhỏ ở vùng cổ hai bên, trong đó một số hạch hơi to nhẹ. Khuyến nghị tái kiểm tra theo dõi.
3. Đại tràng và trực tràng giãn do ứ phân. Khuyến nghị tái kiểm tra theo dõi.
4. Ghi nhận sưng nhẹ mô mềm dưới da dọc theo thành chậu trước bên trái. Khuyến nghị tái kiểm tra theo dõi.

Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh: **Dr. Zhigang Wang**

Lưu ý:

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo cho bác sĩ lâm sàng và không được xem là chứng cứ pháp lý. Báo cáo có được dựa trên việc diễn giải hình ảnh và không phải là quy trình chuẩn hóa tuyệt đối, do đó kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm của bác sĩ đọc phim, mức độ chuẩn bị trước khi chụp, vị trí tổn thương, giai đoạn bệnh và các yếu tố tiền sử bệnh lý khác của thú cưng. Những yếu tố này có thể gây ra sự khác biệt trong việc diễn giải hình ảnh, và báo cáo bằng văn bản có thể không thể phản ánh đầy đủ tất cả các chi tiết trên hình ảnh. Chẩn đoán giải phẫu bệnh hoặc chẩn đoán lâm sàng cuối cùng sẽ được ưu tiên. Các quyết định y khoa liên quan đến kết quả kiểm tra này cần được thực hiện sau khi xem xét đầy đủ các yếu tố nêu trên và có sự tư vấn của bác sĩ lâm sàng.